Árbol de decisión — Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Lumbar. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 9df6c5ab

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿El dolor CENTRALIZA con movimientos repetidos (Método McKenzie/MDT)? 📝 R9

- SÍ → **3 Dolor Radicular Lumbar**
- NO → **3 Dolor Radicular Lumbar**

1c ¿Hay déficit de fuerza, sensibilidad o reflejos en la pierna (comparado con el lado sano)? 📝 R5

- SÍ → **5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)**
- NO → sin hipótesis

sí

1 ¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda? 📝 R1, R2, R4, R6

NO

2 ¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante? 📝 R6, R7, R8

SÍ
SLR positivo <60° o Test de Slump positivo → **→ desvío 1b**

NO
Sin irradiación predominante a la pierna → sin hipótesis

SÍ
Dolor bilateral en glúteos/muslos, alivio con "signo del carrito de compras" → **4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica**

NO
Sin este patrón → sin hipótesis

VASCULAR
Los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie, sin sentarse ni flexionar: sospecha de claudicación vascular → derivación médica → **Derivación médica**
Sospecha de claudicación vascular (los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie): derivación médica para valorar la circulación de las piernas.

Todas → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2

3 ¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante? 📝 G1, G3, G4

todas

4 ¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.) 📝 R3, R6, R9, R10, R11, R12

Agudo/Rigidez
Síntomas <16 días, sin dolor bajo la rodilla y restricción segmentaria hipomóvil → **1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)**

Persistente/Inestabilidad
Dolor en rangos finales o posturas sostenidas con sensación de "fallo" → **2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)**

Ninguno de los dos
Continuar con el patrón de dolor inespecífico → sin hipótesis

DISCOGÉNICO
Dolor en línea media + preferencia direccional o centralización con movimientos repetidos; puede cambiar de lado → **6 Dolor Lumbar Discogénico**

FACETARIO
Paramedial unilateral, dolor en extensión o extensión + rotación, sin pasar de la rodilla; los repetidos no alivian → **7 Dolor Lumbar Facetario**

SACROILÍACA
Dolor en zona de Fortin sin dolor en Tuber, no centraliza → **8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca**

MIOFASCIAL
Banda tensa palpable + punto hipersensible + el paciente reconoce el dolor provocado → **9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar**

NINGUNO
Sin patrón predominante → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor lumbar inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0